

INDICADO POR: Dr. João Carlos	
(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS	
Luciola Helena Ferreira	
IDADE: 56	PESO: 72 ALTURA: 163
PROFISSÃO: Dentista	
SINTOMAS: Refluxo gástrico / acorda cansada / 4 Peso (10kg)	
QUEIXAS: Sonolência diurna / Engasgo.	
MEDICAMENTOS: Clonid. Luvofaxima 150mg / Alopecia (2020)	
MÉDICO: Dr. João Carlos Accarelli	
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N	
EXERCÍCIO FÍSICO: faz em casa 3x	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5	ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 5 20:30
HORA QUE DORME: 00:00	HORA QUE ACORDA: 5:30
COCHILHO: () S () N	DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: (X) S () N 2 /	DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N
BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N todos os dias.	
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	BANHEIRO/NOITE: 0 X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não	MALLAMPATI: II IAH: 26,5 SPO2: 82%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor lombar / cervical	
Cirurgias: () NASAL (N) AMIGDALECTOMIA	
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA	
(S) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA () OUTROS: Porém tem que checar.
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N	SPO2 C/ CPAP: 90 PRESSÃO NO EXAME: 9.0
15/02/25 Avaliação	
29/03/2025 P= 10 cmH2O	
IAH= 5,1 elh (AC: 4,1 elh AO: 0,3.)	
m uso= 6 horas	
fuga= 39 el/min	
Boca seca	
reflexo melhora na	
sonolência diurna	
05/04/2025 P= 10 cmH2O	
IAH= 4,4 elh (AO: 3,3 AO: 0,4)	
m uso= 5h 5 min	
fuga= 39 el/min	
Boca seca / Queixa mto despertan	
+ P: 9,6 cmH2O.	
silva	
10/05	
25 P= 9,6 cmH2O	
IAH= 3,0 elh	
M. de uso: 5h 25'	
Bem adapt.	
guar.	

Dr. or

12/04/25 P=9,6 cmH₂O
IAH=4,4 e/h AC:34
mdc uso: 5h30
fuga: 37,6 l/min

Ouinto ajuste de
mascara. e

↑ tempo de uso
Natacha

07/06
25 De 30d - 22 uso.
P=9,2 cmH₂O
IAH=3,1 e/h
fuga=17,8 l/min

Deixo uma máscara NOVA Pillow
pt teste

26/04/25 P=9,2 cmH₂O
IAH=3,1 e/h (> AC)
mdu=4h36min
fuga=16 l/min

P: 8,8 cmH₂O

usando pillow
gaton.

vai operar dentro septo.

Silvia

Dr. João Carlos Ceccarelli

Otorrinolaringologista - CRM 64.928 - SP - RQE 17264

Luciola Helene Ferreira

Solicitado Teste de Adaptação
ao CPAP. e ponto acurso
segundo laudo Polissonográfico

13/02/

Dr. João Carlos Ceccarelli
Otorrinolaringologista
CRM 64.928
RQE 17264

Tel.: (12) 3951-0466

Consultório: Rua Barão do Rio Branco, 25 - Jd. Santa Maria - Jacareí - SP - CEP 12328-060
E-mail: consultoriojhp@hotmail.com

Nome: LUCIOLA HELENA FERREIRA
Data de Nascimento: 18-10-1968
IMC: 26,35
Sexo: Feminino
Data do exame: 09-08-2024

Peso: 70 kg
Altura: 1,63 m
Médico: DRA. DAYSE RIBEIRO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 09-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 495,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 31,0 e 111,0 minutos. O tempo total de sono foi de 393,5 min, eficiência de 79,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 59,6%; estágio N3: 17,0%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 13,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,5/hora, sendo 63 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 111 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 82%, permanecendo 2,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 92 bpm e NREM de 59 - 95 bpm.

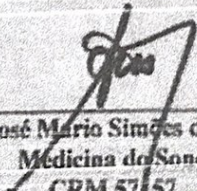
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,6/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157